

消风散对慢性湿疹患者瘙痒症状的缓解效果

黄艳, 周辉, 李培学

贵州中医药大学第一附属医院, 贵州 贵阳 550001

摘要: **目的** 探讨消风散对慢性湿疹患者瘙痒症状的缓解效果。**方法** 选取2023年8月—2024年7月本院收治的慢性湿疹患者60例, 随机将其分为实验组和对照组, 每组30例。对照组采用常规治疗法, 实验组在常规治疗基础上加用消风散进行治疗。观察治疗前后瘙痒症状评分、皮损面积 (EASI评分)、生活质量评分 (DLQI) 及治疗有效率, 进行统计学分析。**结果** 治疗后, 两组瘙痒评分、EASI评分均较治疗前有所改善 ($P<0.05$), 且实验组改善程度优于对照组 ($P<0.05$)。治疗后, 两组患者生活质量评分均较治疗前有所改善 ($P<0.05$), 且实验组改善程度优于对照组 ($P<0.05$)。实验组治疗有效率高于对照组 ($P<0.05$)。**结论** 消风散能够有效缓解慢性湿疹患者瘙痒症状, 减少皮损面积, 提高治疗有效率和患者生活质量, 具有显著的临床应用价值。

关键词: 消风散; 慢性湿疹; 瘙痒症状; 治疗有效率

DOI:10.19335/j.cnki.2096-1219.2025.10.031

The Relieving Effect of Xiaofeng Powder on Pruritus in Patients with Chronic Eczema

HUANG Yan, ZHOU Hui, LI Peixue

The First Affiliated Hospital of Guizhou University of Traditional Chinese Medicine, Guiyang, Guizhou 550001

ABSTRACT: **Objective** To investigate the clinical effect of Xiaofeng Powder on relieving pruritus in patients with chronic eczema, and compare the difference with conventional treatment, so as to provide clinical reference. **Methods** 60 patients with chronic eczema treated from August 2023 to July 2024 were randomly divided into experimental group and control group, with 30 cases in each group. The control group received conventional treatment, and the experimental group received Xiaofeng powder on the basis of conventional treatment. Itch symptom score, skin lesion area (EASI score), quality of life score (DLQI) and treatment efficiency were observed before and after treatment, and statistical analysis was performed. **Results** After treatment, both groups showed improvement in itching score and EASI score compared to before treatment ($P<0.05$), and the improvement in the experimental group was better than that in the control group ($P<0.05$). After treatment, the quality of life scores of both groups of patients improved compared to before treatment ($P<0.05$), and the improvement degree of the experimental group was better than that of the control group ($P<0.05$). The effective rate of treatment in the experimental group was higher than that in the control group ($P<0.05$). **Conclusion** Xiaofeng Powder can effectively relieve pruritus symptoms of chronic eczema patients, reduce skin lesions, improve treatment efficiency and quality of life, and has significant clinical application value.

KEYWORDS: Xiaofengsan; Chronic eczema; Pruritus symptoms; Therapeutic effectiveness

0 引言

慢性湿疹是一种由多种内外因素引发的慢性、反复发作的炎症性皮肤病, 其发病机制复杂, 临床表现以剧烈瘙痒、皮肤苔藓样变为主, 严重影响患者的生活质量。目前, 慢性湿疹的常规治疗多依赖糖皮质激素及抗组胺药物, 但长期应用可能引发不良反应, 且部分患者疗效不佳^[1]。因此, 寻找安全有效的替代或辅助治疗方案尤为重要。中医学认为, 慢性湿疹多

由风、湿、热邪侵袭或脾虚湿盛所致, 其病机以风湿热毒、气血失和为主。消风散作为中医经典方剂, 具有疏风清热、除湿止痒的功效, 在慢性湿疹治疗中已显示出一定的临床价值^[2]。然而, 关于其在缓解瘙痒症状、改善皮损及提高治疗有效率方面的具体疗效尚缺乏系统研究。本研究采用随机对照试验设计, 观察消风散对慢性湿疹患者瘙痒症状、皮损面积、生活质量及治疗有效率的影响, 旨在为中医药治疗湿疹提供科学依据。现将其报告如下。

作者简介: 黄艳 (1980—), 女, 汉族, 贵州贵阳人, 本科, 主治医师, 研究方向: 中医类皮肤专业。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2023年8月—2024年7月某院皮肤科收治的慢性湿疹患者60例为研究对象,采用随机数字表法将其分为实验组和对照组,每组30例。对照组:男12例,女18例;年龄为25~62岁,平均 (42.53 ± 10.12) 岁;病程为6~24个月,平均 (14.37 ± 4.82) 个月。实验组:男14例,女16例;年龄为23~65岁,平均 (43.27 ± 11.45) 岁;病程为7~26个月,平均 (15.08 ± 5.36) 个月。两组患者性别、年龄、病程等一般资料对比,差异无统计学意义($P>0.05$),具有可比性。

纳入标准:①符合慢性湿疹的国际诊断标准,病程 ≥ 6 个月;②年龄在18~65岁,性别不限;③病情稳定,不在急性加重期;④自愿参与本研究,并签署知情同意书。

排除标准:①合并严重系统性疾病或免疫系统功能障碍;②对研究药物中任何成分过敏者;③妊娠或哺乳期妇女;④近期(4周内)使用过糖皮质激素或免疫抑制剂。

1.2 方法

对照组采用常规治疗方法,包括外用中效糖皮质激素乳膏和口服抗组胺药物。具体而言,将糖皮质激素乳膏(如醋酸氟轻松乳膏)每日涂抹于患处2次,疗程4周,使用时避免破损皮肤及感染性病灶。同时,口服抗组胺药物(如盐酸左西替利嗪片,每日10 mg)用于缓解瘙痒症状,疗程与外用治疗同步。治疗期间患者应避免过度搔抓,并尽量避免接触已知的过敏原,同时确保患处保持清洁和干燥。实验组在对照组治疗基础上联合应用消风散治疗,具体方法如下。

(1) 药物:由荆芥、防风、苦参、牛蒡子、蝉蜕、木通、石膏、知母、当归、生地黄、胡麻仁、甘草等组成。药物根据传统中医药理论按比例配伍,经专业药剂师称量后煎煮。

(2) 煎煮与服用方法:每剂消风散药物总量为150 g,加水煎煮2次,每次加水至药材浸没3~5 cm,煎煮40 min,合并两次煎液约400 mL,分早晚两次服用,每日1剂,连续服用4周。叮嘱患者避免空腹服用,以减少对胃肠道的刺激^[3]。

(3) 治疗期间注意事项:①在饮食禁忌方面,患者在治疗期间应避免摄入辛辣刺激性食物及易致敏的海鲜等食品,并应戒酒,减少高糖和高脂食物的摄入

量。②在生活调节方面,建议患者保持良好的睡眠习惯,减少情绪波动,避免剧烈运动或大量出汗对皮肤造成的刺激。③在皮损护理方面,应定期清洗患处,涂抹润肤剂(如尿素软膏)以减少皮肤干燥。对于有感染风险者,应及时采取措施处理。

1.3 观察指标

(1) 瘙痒症状评估:根据患者主观感受采用数字评分法(0~10分)评估,0分为无瘙痒,10分为最严重瘙痒,评分越高表示瘙痒程度越严重。

(2) 皮损面积评估:采用湿疹面积与严重程度指数(EASI)评分法,评估患者皮损面积及红斑、浸润/肥厚、抓痕、苔藓化等严重程度。该法总分为0~72分,分值越高表示皮损越严重。

(3) 生活质量:采用皮肤病生活质量指数(DLQI)问卷评估患者治疗前后生活质量。问卷共有10个条目,总分为0~30分,分值越高表示生活质量受损越严重。

(4) 治疗有效率:根据患者症状改善程度分为显效(瘙痒缓解 $\geq 75\%$,皮损面积减少 $\geq 75\%$)、有效(瘙痒缓解50%~74%,皮损面积减少50%~74%)、无效(瘙痒缓解 $< 50\%$,皮损面积减少 $< 50\%$)。治疗有效率=(显效+有效病例数)/总病例数 $\times 100.00\%$ 。

1.4 统计学处理

采用SPSS 25.0统计软件分析处理数据。计量资料以均数 $\pm$ 标准差($\bar{x} \pm s$)表示,组间比较采用独立样本 t 检验,组内治疗前后比较采用配对 t 检验;计数资料以率或百分比表示,组间比较采用 χ^2 检验。以 $P<0.05$ 为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者瘙痒症状缓解情况以及皮损面积对比

治疗前,两组瘙痒评分、EASI评分比较,差异无统计学意义($P>0.05$);治疗后,两组瘙痒评分、EASI评分均较治疗前有所改善($P<0.05$),且实验组改善程度优于对照组($P<0.05$)。见表1。

表1 两组患者瘙痒症状缓解情况以及皮损面积对比
($\bar{x} \pm s$, 分)

组别	例数	瘙痒评分		EASI 评分	
		治疗前	治疗后	治疗前	治疗后
对照组	30	7.12 $\pm$ 0.83	5.63 $\pm$ 0.57	12.37 $\pm$ 1.45	8.93 $\pm$ 1.37
实验组	30	7.14 $\pm$ 0.82	3.25 $\pm$ 0.42	12.43 $\pm$ 1.48	6.12 $\pm$ 1.24
t	—	0.158	9.721	0.207	8.435
P	—	0.742	< 0.05	0.645	< 0.05

2.2 两组患者生活质量评分对比

治疗前, 两组生活质量评分比较, 差异无统计学意义 ($P>0.05$); 治疗后, 两组患者生活质量评分均较治疗前有所改善 ($P<0.05$), 且实验组改善程度优于对照组 ($P<0.05$)。见表2。

表2 两组患者生活质量评分对比 ($\bar{x} \pm s$, 分)

组别	例数	治疗前	治疗后
对照组	30	18.34 $\pm$ 2.56	15.43 $\pm$ 2.57
实验组	30	18.37 $\pm$ 2.49	12.75 $\pm$ 2.34
t	—	1.057	6.214
P	—	0.098	<0.05

2.3 两组治疗有效率对比

实验组治疗有效率高于对照组 ($P<0.05$)。见表3。

表3 两组治疗有效率对比 [n (%)]

组别	例数	痊愈	显效	有效	无效	总有效率
对照组	30	8(26.67)	10(33.33)	5(16.67)	7(23.33)	23(76.67)
实验组	30	15(50.00)	12(40.00)	1(3.33)	2(6.67)	28(93.33)
χ^2	—	—	—	—	—	5.812
P	—	—	—	—	—	0.016

3 讨论

慢性湿疹是一种由遗传因素、环境因素及免疫异常等多种因素共同作用引发的慢性、复发性、炎症性皮肤病, 其核心病理机制包括免疫紊乱、皮肤屏障功能受损以及炎症因子释放。在慢性湿疹的病理生理过程中, Th1/Th2细胞失衡、IgE水平升高以及炎症介质(如IL-4、IL-13)的过度释放被认为是关键环节。此外, 环境刺激、心理压力及饮食不当等外因也在湿疹的复发与加重中起到重要作用。传统治疗方案主要包括糖皮质激素、抗组胺药物以及免疫抑制剂的使用, 这些药物虽能在短期缓解症状, 但长期使用可能导致副作用, 且在改善患者长期生活质量方面效果有限。

中医理论认为, 慢性湿疹的发病主要与风、湿、热毒内侵以及气血失和有关, 病机复杂, 涉及多个脏腑功能失调。中医治疗强调整体调节, 通过疏风清热、除湿止痒、活血化瘀等方法改善病症。消风散作为中医经典方剂, 具有调节内外平衡、恢复机体正常功能的作用, 尤其适用于湿疹等与湿热邪毒密切相关的疾病。王晶晶^[4]研究表明, 消风散在降低湿疹患者瘙痒症状和皮损面积方面疗效显著, 其作用机制是通过调节免疫功能, 减少炎症因子的释放, 同时改善皮肤屏障功能, 进一步降低疾病复发率。这些研究结果与中医“祛风通络, 清热除湿”的理论相一致, 为慢性湿疹的长期治疗提供了可靠依据。

近年来, 基于传统方剂的加减应用在湿疹的治疗中取得了更多进展。四物消风散作为消风散的经典改良方, 进一步强化了消风散的补血、活血作用。李章利等^[5]通过对慢性湿疹患者的临床研究发现, 四物消风散加减方不仅能显著提高治疗有效率, 还在安全性方面表现良好, 避免了糖皮质激素等西药可能引发的副作用。这种基于个体化加减的中药方案, 不仅拓宽了湿疹治疗的应用范围, 还为湿疹的中医辨证治疗提供了理论与实践依据。通过个性化治疗, 中医药的整体调节作用得以更充分地发挥。

联合方剂的应用也是近年来慢性湿疹中医治疗的研究热点。许焕利^[6]通过玉屏风散联合消风散加减治疗慢性湿疹的研究指出, 这种联合治疗通过多靶点调节机体功能, 增强了对湿疹病机的综合干预作用。研究结果表明, 联合治疗对顽固性湿疹患者具有更显著的疗效, 在改善瘙痒症状和皮损面积的同时, 还显著提高了患者的生活质量。这些结果表明, 联合治疗在复杂湿疹病例中具有较高的推广价值, 并进一步验证了“标本兼治”的中医治疗思路。

对于特殊部位湿疹, 如慢性肛门湿疹, 消风散也显示出其独特优势。戴佳吟^[7]研究发现, 四物消风散通过调节机体内外环境平衡, 有效缓解了血虚风燥证导致的瘙痒症状及皮损表现。该研究强调, 消风散不仅具有清热除湿作用, 还能通过补血润燥的效果改善特殊部位湿疹的难治情况。这一发现扩展了消风散的适应证范围, 同时为中医治疗不同证型的慢性湿疹提供了理论支持。

结合上述文献, 消风散及其加减方剂不仅在慢性湿疹的整体治疗中表现出显著优势, 还具有改善患者生活质量、降低疾病复发率的潜力。

本研究结果显示, 治疗后, 两组瘙痒评分、EASI评分均较治疗前有所改善 ($P<0.05$), 且实验组改善程度优于对照组 ($P<0.05$), 实验组患者的生活质量评分显著优于对照组 ($P<0.05$), 进一步说明消风散能够显著改善患者的生活质量。此外, 实验组患者的治疗有效率明显高于对照组 ($P<0.05$), 提示消风散在改善瘙痒症状和皮损方面的整体疗效更加显著。

综上所述, 消风散在治疗慢性湿疹中显示出显著的临床优势, 能够有效缓解瘙痒症状, 减少皮损面积, 提高生活质量和治疗有效率。该法作为一种安全有效的治疗方案, 具有重要的推广价值。未来的研究应通过多中心、大样本研究进一步验证其临床价值。

(下转第117页)

是：孟鲁司特钠通过抑制白三烯介导的炎症反应抑制腺样体增生，减轻黏膜水肿；内舒拿通过减轻鼻黏膜充血水肿，改善通气，通过局部抗炎作用减轻腺样体肥大；匹多莫德有助于提高呼吸道免疫力。三种药物联合使用发挥协同作用，可以减轻腺样体肥大，使患儿的鼻阻塞症状减轻，有效缓解睡眠障碍。本研究结果显示，联合组不良反应占比略高于对照组，但两组比较未见明显差异，表明联合用药不会增加不良反应。

综上所述，在孟鲁司特钠、内舒拿的基础上加用匹多莫德有助于减轻患儿炎症反应，增强免疫力，改善睡眠障碍和腺样体肥大，且安全性好。

参考文献

- [1] 霍红梅,许文婷,马艳艳,等.化痰消结汤联合孟鲁司特治疗痰瘀互结证儿童腺样体肥大的效果[J].西北药学杂志,2023,38(2):176-179.
- [2] 张冰,于娟.半胱氨酰白三烯在腺样体肥大患儿中的表达特点[J].智慧健康,2020,6(7):151-152,161.
- [3] 陈谊辉,杨爱叶,陈鹏,等.鼻用激素与孟鲁司特钠联合对腺样体肥大患儿睡眠质量及临床疗效的影响[J].中国儿童保健杂志,2022,30(1):93-96.
- [4] 金冠杰,赵焱,赵晓云.匹多莫德联合吸入用布地奈德混悬液治疗反复性呼吸道感染患儿的临床研究[J].中国临床药理学杂志,2024,40(3):307-311.
- [5] 江载芳,申昆玲,沈颖.诸福棠实用儿科学[M].8版.北京:人民卫生出版社,2015:2546-2547.
- [6] 霍红梅,许文婷,刘春兰,等.六君消瘰汤加减结合雷火灸治疗小儿腺样体肥大(肺脾气虚证)临床疗效及安全性观察[J].中华中医药学刊,2022,40(7):213-216.
- [7] 刘晓峰,杜娟,崔莉,等.鼻用糖皮质激素联合白三烯受体拮抗剂对有合并症小儿腺样体肥大疗效及炎症因子的影响[J].中国优生与遗传杂志,2022,30(12):2179-2183.
- [8] 安冉,李玉晓.孟鲁司特钠联合鼻用激素治疗腺样体肥大患儿的疗效[J].中国妇幼保健,2021,36(15):3491-3494.
- [9] WANG Z, WU X, LIU J, et al. Effects of oral cysteine leukotriene receptor antagonist-montelukast on adenoid lymphoid tissue: a histopathological study under light microscope[J]. Front Pharmacol. 2023(14):1285647.
- [10] 靳千城,耿少怡,王轻轻,等.慈菰散结方联合糠酸莫米松鼻喷雾剂治疗儿童腺样体肥大临床疗效观察[J].广州中医药大学学报,2022,39(4):805-811.
- [11] 屈昕,王辉,崔巧梅,等.匹多莫德联合孟鲁司特钠对阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征患儿认知功能的影响[J].国际精神病学杂志,2020(1):141-143,147.

(上接第113页)

参考文献

- [1] 耿雪松,王微.养血祛风汤辅助治疗血虚风燥型慢性湿疹患者的效果[J].智慧健康,2024,10(26):97-99.
- [2] 王小勇,杨勇.疏风燥湿解毒汤治疗慢性湿疹27例[J].实用中医药杂志,2024,40(11):2171-2172.
- [3] 田新科.消风散加减配合三棱针刺络治疗慢性湿疹疗效观察[J].实用中医药杂志,2023,39(7):1306-1308.
- [4] 王晶晶.消风散加减治疗湿疹的临床疗效评价[J].内蒙古中医药,2023,42(4):54-55.
- [5] 李章利,龚致平.四物消风散加减方治疗慢性湿疹的有效性及安全性分析[J].医学食疗与健康,2021,19(9):17,184.
- [6] 许焕利.玉屏风散合消风散加减治疗慢性湿疹50例的临床效果[J].医学食疗与健康,2020,18(13):32,34.
- [7] 戴佳吟.四物消风散治疗慢性肛门湿疹(血虚风燥证)的疗效观察[D].长沙:湖南中医药大学,2020.